جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : مني محمد شحاته فرحات
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** حلوان **العنوان :** حلوان
رقم البطاقة : 27005050200268 **رقم التليفون :** 01220260134 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 15-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 05-05-1970 **المهنة :** بدون عمل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: منى محمد شحاته فرحات
National ID: 27005050200268

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Supportive and palliative Treatment**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

منى
محمد شحاته فرحات عمر

٣ عرب راشد
حلوان - القاهره

٢٧٠٠٥٠٥٠٢٠٠٢٦٨

KY2722292

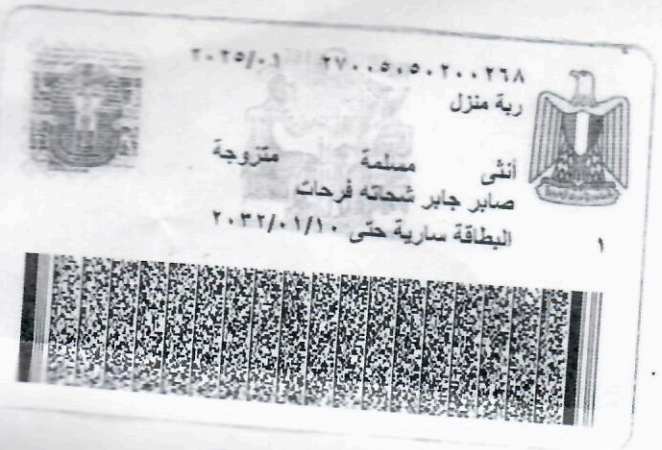
١٢٤٠٦٢٠١٢٤

٠١١٤٥٧٤٤٨٤٩

٦ ←

٨/١٦

عسى



٢٧٠٠٥٠٥٠٢٠٠٢٦٨ ٢٠٢٥/٠١

ربة منزل

أنثى مسلمة متزوجة

صابر جابر شحاته فرحات

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠١/١٠

١

اقرأ السائل ع رفع

National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

١٠٠ مليون
صحة



الست المصرية هي صحة مصر

منظمة الصحة العالمية

وزارة الصحة والسكان

presidential-initiative-card
[[DOCTYPE-OTHER_PRESEDENTIAL_INITIATIVE_CARD]]

الاسم: سنى محمد شعبان غرشات التاريخ:

الرقم القومي: ٢٧٠٠٥٠٥٠٥٠٢٦٨

رقم التليفون: ٠١٤٥٧٢٢٨٢٩

مستهدفة بالتوعية ◯

مستهدفة بالتوعية والفحص الإكلينيكي ◯

الوزن	الطول	مؤشر كتلة الجسم	قياس السكر العشوائي	قياس ضغط

* فكري نفسك باستمرار بموعد الفحص الذاتي شهريًا

يوليو	2019		أغسطس	2019		سبتمبر	2019
أكتوبر	2019		نوفمبر	2019		ديسمبر	2019
يناير	2020		فبراير	2020		مارس	2020
أبريل	2020		مايو	2020		يونيو	2020
يوليو	2020		أغسطس	2020		سبتمبر	2020
أكتوبر	2020		نوفمبر	2020		ديسمبر	2020
يناير	2021		فبراير	2021		مارس	2021
أبريل	2021		مايو	2021		يونيو	2021

- حافظي علي قياس السكر والضغط مرة كل ٦ شهور.
- إذا كنتي في سن الزواج أو الإنجاب، إستشيري بإنتظام طبيب تنظيم الأسرة.
- إطمني ، الكشف المبكر بيساعد في السيطرة على الأمراض، وزيادة نسب الشفاء.

موعد الفحص القادم: توقيع الطبيب:

المكان المحولة له للتقييم: موعد التقييم:

15335 www.100millionseha.eg

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية للنظم المعلومات و التحول الرقمى

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار :16-8-2026

جهه الاصدار :فرع القاهرة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطيقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) منى محمد شحاته فرحات بطاقة رقم 27005050200268

تليفون رقم: 01145722829

وطيقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه :16-8-2026

الموظف المختص

محمود عبدالله

افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،

مسلسل 2050886

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزراة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

Non-HIO Letter
[[DOCTYPE:NON_HIO_LETTER]]

اسم المريض بالإنجليزية: Mona Mohamed Shehatah Farahat	كود المريض: 98446
تاريخ التقرير: 2026/08/16 11:05:56 AM	السن: ٥٦ سنة, ٣ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 57 years old female patient with right breast lump.

Detailed Findings

Right breast:

- (ACR density A).
- The right breast shows middle 1/3 ill-defined spiculated dense mass lesion measuring about 2.4 x 2.4 cm with architectural distortion and located at lower central region and about 5.2 cm from the nipple.
- **Ultrasound** revealed ill-defined hypoechoic mass lesion measures about 18 x 17 mm at its maximum diameters and located at 6 ° clock position and about 10 mm from the skin and about 2.7 cm.
- Normal nipple/areolar complex.
- Multiple enlarged axillary lymph nodes at level I with effaced hila, largest one measures about 13 x 6.5 mm.

Left breast:

- (ACR density A).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Right breast (BIRADS 5): Right lower central malignant mass lesion with ipsilateral pathological axillary lymph nodes as described, tru cut biopsy was done on the same setting.**
- **Left breast (BIRADS 2): left normal study.**

Much obliged,
Dr. Hedaya Nour, MD

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]
National ID – Front & Back

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



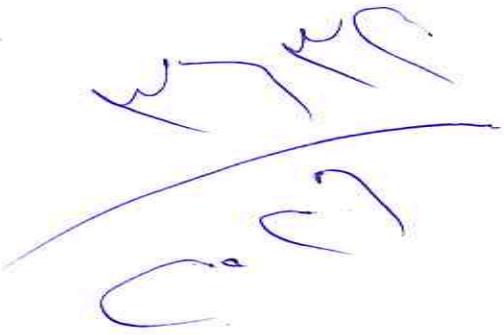
منى
محمد شحاته فرحات عمر
٣ عرب راشد
حلوان - القاهره

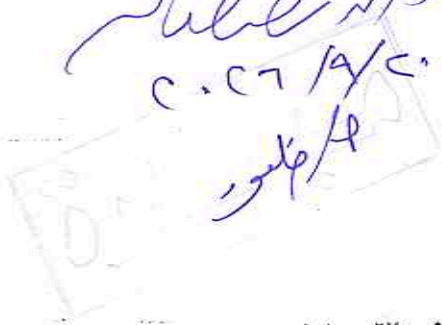
٢٧٠٠٥٠٥٠٢٠٠٢٦٨

KY2722292







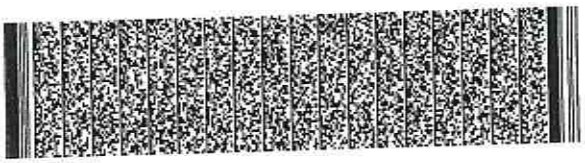




٢٧٠٠٥٠٥٠٢٠٠٢٦٨ ٢٠٢٥/٠١
ربة منزل

أنثى مسلمة متزوجة
صابر جابر شحاته فرحات
١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠١/١٠





GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL
Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناشونال – مصر معمل البيثولوجي
جوستاف روسي

Patient Name	منى محمد شحاته	**Case No.**	**358698**
Sex/Age	**Female 56 Y**	**Patient No.**	**26002**
Registered Date	**17/8/2026 02:29:34 PM**	**Referred By Dr.**	**Out Patient**
Validation Date	**07/9/2026 02:21:08 PM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**17/9/2026 12:44:32 PM**	**Pathology No.**	**2617/26**

Pathology Report

Clinical Data: Right breast lower central mass (BIRADS 5), with pathological ipsilateral lymph node.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 17/08/2026, at 11:39 am. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:
- Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.5 cm & 1.2 cm long, totally submitted.

Technique:
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:
-Histologic type: Invasive duct carcinoma.
- Histologic grade: 2 (Differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1).
- DCIS: Absent.
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.

Results:
* IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 98% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Negative membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67%: 30%.

Conclusion:
Right breast mass, Tru-cut biopsy:
-Invasive duct carcinoma, Grade 2.
IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Negative (score 0).

[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]
Pathology Report

Patient Name	منى محمد شحاته	**Case No.**	**358698**
Sex/Age	**Female 56 Y**	**Patient No.**	**26002**
Registered Date	**17/8/2026 02:29:34 PM**	**Referred By Dr.**	**Out Patient**
Validation Date	**07/9/2026 02:21:08 PM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**17/9/2026 12:44:32 PM**	**Pathology No.**	**2617/26**

- Ki67%: 30%.

***Scoring system: "ER, PR"**
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%
and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

*** Scoring system: "Her2"**
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature:
Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.

[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]
Mammogram

Mona Mohamed Shehatah Farahat :اسم المريض بالإنجليزية	كود المريض: 98446
تاريخ التقرير: 2026/08/16 11:05:56 AM	السن: ٥٢ سنة ٣ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 57 years old female patient with right breast lump.

Detailed Findings

Right breast:

- (ACR density A).
- The right breast shows middle 1/3 ill-defined spiculated dense mass lesion measuring about 2.4 x 2.4 cm with architectural distortion and located at lower central region and about 5.2 cm from the nipple.
- **Ultrasound** revealed ill-defined hypoechoic mass lesion measures about 18 x 17 mm at its maximum diameters and located at 6 ° clock position and about 10 mm from the skin and about 2.7 cm.
- Normal nipple/areolar complex.
- Multiple enlarged axillary lymph nodes at level I with effaced hila, largest one measures about 13 x 6.5 mm.

Left breast:

- (ACR density A).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Right breast (BIRADS 5): Right lower central malignant mass lesion with ipsilateral pathological axillary lymph nodes as described, tru cut biopsy was done on the same setting.**
- **Left breast (BIRADS 2): left normal study.**

Much obliged,
Dr. Hedaya Nour, MD

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



منى
محمد شحاته فرحات عمر
٣ عرب راشد
حلوان - القاهره

٢٧٠٠٥٠٥٠٢٠٠٢٦٨

١٩٧٠/٠٥

KY2722292

فتح ملف عمره
د/ عصام
٢٠٢٦/٩/٢٠
م/ ملف

٢٧٠٠٥٠٥٠٢٠٠٢٦٨ ٢٠٢٥/٠١
ربة منزل

أنثى مسلمة متزوجة
صابر جابر شحاته فرحات
١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠١/١٠

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL HOSPITAL
Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناشونال – مصر معمل البيثولوجي
جوستاف روسي

Patient Name	منى محمد شحاته	**Case No.**	**358698**
Sex/Age	**Female 56 Y**	**Patient No.**	**26002**
Registered Date	**17/8/2026 02:29:34 PM**	**Referred By Dr.**	**Out Patient**
Validation Date	**07/9/2026 02:21:08 PM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**17/9/2026 12:44:32 PM**	**Pathology No.**	**2617/26**

Pathology Report

Clinical Data: Right breast lower central mass (BIRADS 5), with pathological ipsilateral lymph node.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 17/08/2026, at 11:39 am. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:
- Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.5 cm & 1.2 cm long, totally submitted.

Technique:
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:
-Histologic type: Invasive duct carcinoma.
- Histologic grade: 2 (Differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1).
- DCIS: Absent.
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.

Results:
* IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 98% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Negative membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67%: 30%.

Conclusion:
Right breast mass, Tru-cut biopsy:
-Invasive duct carcinoma, Grade 2.
IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Negative (score 0).

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL
Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناشونال – مصر معمل الباثولوجي
جوستاف روسي

Patient Name	منى محمد شحاته	**Case No.**	**358698**
Sex/Age	**Female 56 Y**	**Patient No.**	**26002**
Registered Date	**17/8/2026 02:29:34 PM**	**Referred By Dr.**	**Out Patient**
Validation Date	**07/9/2026 02:21:08 PM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**17/9/2026 12:44:32 PM**	**Pathology No.**	**2617/26**

- Ki67%: 30%.

***Scoring system: "ER, PR"*
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%
and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

*** Scoring system: "Her2"*
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature:
Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.

Mona Mohamed Shehatah Farahat :اسم المريض بالإنجليزية	كود المريض: 98446
تاريخ التقرير: 2026/08/16 11:05:56 AM	السن: ٥٧ سنة, ٣ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 57 years old female patient with right breast lump.

Detailed Findings

Right breast:

- (ACR density A).
- The right breast shows middle 1/3 ill-defined spiculated dense mass lesion measuring about 2.4 x 2.4 cm with architectural distortion and located at lower central region and about 5.2 cm from the nipple.
- **Ultrasound** revealed ill-defined hypoechoic mass lesion measures about 18 x 17 mm at its maximum diameters and located at 6 ° clock position and about 10 mm from the skin and about 2.7 cm.
- Normal nipple/areolar complex.
- Multiple enlarged axillary lymph nodes at level I with effaced hila, largest one measures about 13 x 6.5 mm.

Left breast:

- (ACR density A).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Right breast (BIRADS 5): Right lower central malignant mass lesion with ipsilateral pathological axillary lymph nodes as described, tru cut biopsy was done on the same setting.**
- **Left breast (BIRADS 2): left normal study.**

Much obliged,
Dr. Hedaya Nour, MD

[[DOCTYPE:MDT_FORM]]
MDT Form

جوستاف روسي

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

10/11/2026

MDT FORM

Name:	منى محمد شحاته فرحات	**MRN:**	14070
Age:	56 Y	**ID:**	27005050200268
Menopausal Sta	POST	**Phone:***	01145722829
NRS SCORE:		**Marital Status:**	
BMI:		**Family History:**	+VE FH SISTER
Gender			
CO Morbidity:	HTN	**Reason Of MDT:**	NEW CASE
Surgical History:*	NAD	**ECOG Performance Status**	○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4

Clinical Data:

BX: RT IDC G2

ER: 8/8 **PR:** 8/8 **HER2:** 0 **KI67:** 30%

History:

Sonomammography:

SM ACR A RT 2.4*2,4 CM MASS WITH ARCHETICTURAL DISTORTION AT 6 OCLOCK 5.2 CM ABOT 10 MM FROM SKIN WITH MULTIPLE ENLARGED AXILLARY LN LEVEL 1 1.3*6,5 MM BIRADS 5

Biomarker/Molecular

Mets Workup:

CT CAP >> LT KIDNEY LOWER POLE UNILOCULAR CYST 5*4 CM
RT THICKNED ADRENAL GLAND LIKELY HYPERPLASIA

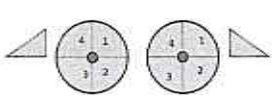
Recommendations:

FOR POSSIBILITY OF CLIPPING NACT THEN RT BCS & SLNB

MDT Outcome & Plan

FOR CLIPPING
NACT (AC*4 THEN TACOL WEEKLY *12 WEEK)
THEN RT BCS & SLNB

R L



T N M

Right Side				Left Side			
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

Clinical Staging:

Pathological Staging:

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د حنان عزت	د احمد نجيب		